UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS · ÁREA RESPIRATORIA

Protocolo de decúbito prono

Posicionamiento en prono del paciente con SDRA en ventilación mecánica invasiva: indicación, técnica de giro, posiciones y cuidados.

CÓDIGO	DP-01
VERSIÓN	1.0
ÁMBITO	UCI adultos
DIRIGIDO	Médicos · DUE · TCAE · Celadores
REVISIÓN	____ / ____ / ______
PÁGINAS	6

DEF. Estrategia capaz de **mejorar la oxigenación arterial** en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) tratados con ventilación mecánica.

01 INDICACIONES Criterios de inclusión

PAO_2 / FIO_2	FIO_2	PEEP	EVOLUCIÓN
< 150 mmHg	**≥ 0,6**	**> 5** cmH_2O	**< 7** días
Hipoxemia grave	Requerimiento de oxígeno	Pese a ventilación protectora	Desde la lesión pulmonar

Más efectivo si se realiza antes de una semana tras la aparición de la lesión pulmonar.

12 – 18 h	Duración de cada sesión en prono	**4 sesiones**	Media por paciente

02 VALORACIÓN DE LA RESPUESTA



Giro
Cambio postural a decúbito prono.

30 – 60 min
Se observa la respuesta en la oxigenación.

Hasta 2 h
Si no responde, prolongar la prueba para detectar respondedores tardíos.

Día siguiente
Repetir si el paciente todavía reúne criterios.

20 – 40 % de los pacientes son **no respondedores**.

03 VENTAJAS FISIOLÓGICAS

- Incremento de la capacidad residual funcional pulmonar.
- Cambios en la movilidad diafragmática.
- Evacuación de las secreciones.
- Mejoría de la relación ventilación / perfusión.

04 CONTRAINDICACIONES

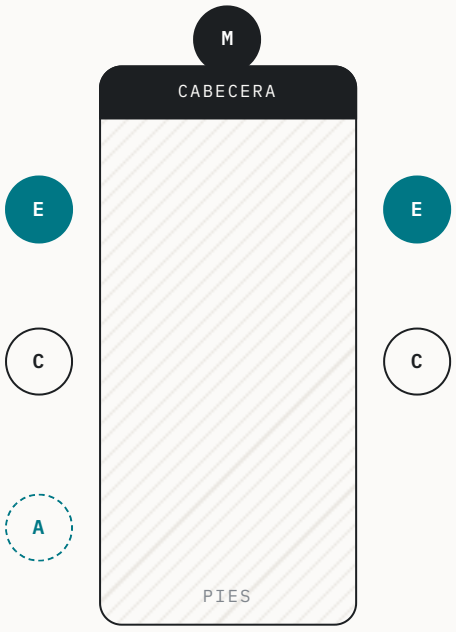
ABSOLUTAS	RELATIVAS
■ Fracturas vertebrales inestables con tracción esquelética. ■ Fracturas pélvicas. ■ Heridas abiertas en la zona ventral o en la cara.	■ Presión intracraneal elevada. ■ Inestabilidad hemodinámica. ■ Grandes quemados. ■ Esternotomía. ■ Laparotomía. ■ Gestación 2.º trimestre.

05 COMPLICACIONES Vigilar activamente

- **Extubación accidental** (ExIOT).
- **Pérdida de vías** y accesos vasculares.
- Daños neuromusculares por la postura.
- Edema facial.
- Desaturación ocasional en los primeros minutos tras el giro.

06 EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN

MÍNIMO 4 – 6 PERSONAS



1 Médico · cabecera
Dirige el proceso y controla el tubo endotraqueal (TET) y la SNG.

2 Enfermeras · una a cada lado
Vigilan accesos vasculares y drenajes.

2 Celadores · zona tóraco-abdominal
Uno a cada lado; encargados de girar al paciente.

1 Auxiliar de enfermería · soporte
Colabora en el desplazamiento de las extremidades inferiores.

07 RECURSOS MATERIALES Comprobar antes de iniciar

- [ ] Cama articulada con colchón antiescaras
- [ ] Sábanas
- [ ] Empapadores
- [ ] Almohadas largas
- [ ] Almohadas pequeñas o rodillos
- [ ] Alargaderas
- [ ] Electrodos
- [ ] Anillo protector para cara y TET
- [ ] Bolsa colectora para SNG
- [ ] Material de intubación
- [ ] Carro de paradas en la puerta del box CRÍTICO
- [ ] Ambú y mascarilla conectada a O_2 CRÍTICO
- [ ] Aspirador de secreciones y sondas
- [ ] Pulsioximetría

08 PREPARACIÓN DEL PACIENTE Checklist pre-giro

- [ ] **Suspender NE.** Comprobar la SNG y que no haya restos. Conectar SNG a bolsa.
- [ ] Limpiar, lubricar y ocluir los ojos con apósitos.
- [ ] Curas de heridas situadas en la parte ventral.
- [ ] Recolocar las bombas de perfusión en el lado de la cama donde quedará el acceso venoso tras el giro.
- [ ] Bolsa de orina **pinzada** y drenajes torácicos a los pies de la cama, entre las piernas.
- [ ] **Comprobar fijación del TET** y holgura suficiente de las tubuladuras del respirador.
- [ ] Aspirar secreciones bronquiales y cavidad bucal.
- [ ] Retirar electrodos y desconectar los cables de medición no imprescindibles.

09 PROCEDIMIENTO DE GIRO



FIG. A Desplazar al extremo contrario; brazo bajo el glúteo.



FIG. B Decúbito lateral; almohadas en escápulas, cadera y tobillos.



FIG. C Giro sobre las almohadas a decúbito prono.

GIRO

01	Desplazar al paciente hasta el extremo de la cama **contrario al sentido del giro**.	FIG. A
02	Situar el brazo que queda en el centro de la cama con la **palma hacia arriba y debajo del glúteo** (evita la luxación de hombro) y girar a decúbito lateral en el centro de la cama.	FIG. A–B
03	Colocar almohadas junto al paciente a la altura de **escápulas, cadera y tobillos**. En la cabeza, un empapador para la saliva con un rodete o toalla debajo.	FIG. B
04	Girar al paciente sobre las almohadas en **decúbito prono**.	FIG. C
05	Centrar al paciente comprobando la correcta alineación corporal.	

TRAS EL GIRO

06	Volver a monitorizar constantes; comprobar ventilación y estado hemodinámico; valorar nuevas calibraciones.	
07	Revisar la situación del TET y el funcionamiento de accesos vasculares y drenajes.	
08	Cabeza y brazos en posición fisiológica; cama en **antitrendelenburg** `10–15°` para evitar RGE y disminuir el edema facial.	§10
09	Bolsa de orina en un lateral, tubuladura por debajo de la pierna y sonda entre las piernas; **despinzar**.	
10	Reanudar la nutrición enteral y recolocar aparatos si fuese preciso.	

10 POSICIONES EN DECÚBITO PRONO



FIG. 1 · Cabeza lateralizada sobre rodete

10.1 Cabeza y columna cervical

Cabeza apoyada sobre un lado, ligeramente lateralizada, evitando la extensión excesiva. Toalla o rodete en **«C»** con la zona abierta hacia la cara: máxima superficie de apoyo sin comprimir el TET, permitiendo cuidados bucales y drenaje de saliva. La elevación de la cabeza debe ser similar a la de la cintura escapular para no forzar la flexión.

`Rodete en «C»` `Sin compresión del TET` `Drenaje de saliva`



FIG. 2 · Brazos alternos, cabeza hacia el brazo caudal

10.2 Extremidades superiores

Brazo a lo largo del cuerpo: rotación interna, palma hacia arriba, codo y hombro flexionados 20–30°. **Brazo por encima de la cabeza:** rotación externa, codo y hombro a 90°, con rodete en la mano.

`Brazo caudal 20–30°` `Brazo craneal 90°` `Rodete en mano`



FIG. 3 · Almohada escapular, abdomen libre

10.3 Cintura escapular

Almohada a la altura de las escápulas: eleva el tórax y reduce el peso sobre las mamas (evita necrosis de pezón). Elevar cintura escapular y pélvica libera abdomen y diafragma, favoreciendo los movimientos respiratorios.

`Abdomen libre` `Protección mamaria`



FIG. 4 · Almohadas en crestas ilíacas y zona pretibial

10.4 Cintura pélvica

Almohada a la altura de las crestas ilíacas: eleva la pelvis, protege la columna lumbar de la hiperextensión y alivia el peso sobre la articulación coxofemoral.

`Crestas ilíacas` `Evita hiperextensión lumbar`

10.5 Extremidades inferiores

Almohada en zona pretibial, bajo los tobillos: pie alineado a 90° con la pierna, evitando el pie equino. La elevación produce una ligera flexión de rodillas (20–30°) que libera tensiones articulares.

`Pie a 90°` `Rodillas 20–30°` `Prevención pie equino`

REGLA La **cabeza siempre girada hacia el brazo situado a lo largo del cuerpo**, para disminuir la tensión sobre ambos plexos braquiales. Mantener esta relación en todos los cambios posturales.

11 CUIDADOS ESPECÍFICOS Cronograma de 24 h

■ Cambio postural (cabeza/brazos) ■ Cuidado ocular ■ Aspirado gástrico

HORA DE SESIÓN	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Cambio postural	■			■			■			■			■			■			■			■		
Cuidado ocular	■						■						■						■					
Aspirado gástrico	■						■						■						■					
Duración en prono	12 h → 18 h																							

01 Alineación corporal CONTINUO

Revisar periódicamente la alineación correcta. Cabecero a **30–45°**.

02 Cambios posturales C/ 3 H

Alternar la postura de los brazos coordinada con el giro de la cabeza (siempre hacia el brazo a lo largo del cuerpo): ambos brazos a lo largo del cuerpo → aspirar cavidad bucal → sujetando TET y SNG, girar la cabeza elevándola ligeramente → acomodar rodete → elevar el brazo correspondiente. Si está indicado, semidecúbito lateral **20–30°** con una almohada bajo un lateral del colchón, manteniendo el DP.

03 Cuidados oculares C/ 6 H

Levantar apósitos, valorar edema orbital y conjuntiva, limpiar secreciones y lubricar con lágrimas artificiales y pomada epitelizante. Puede coincidir con el cambio de la cabeza.

04 Vigilancia respiratoria, accesos vasculares y TET CONTINUO

Evitar acodaduras y tracciones; el TET debe conservar una postura anatómica sin lesionar la zona bucal.

05 Higiene general en decúbito lateral DIARIO

1. Brazos a lo largo del cuerpo, palmas hacia arriba. Aspirado e higiene bucal (y bronquial si precisa).
2. Retirar almohadas y rodete. La mano del brazo que quedará debajo, bajo el muslo con la palma hacia arriba.
3. A decúbito lateral mientras la enfermera sujeta TET y SNG desde la cabecera. Higiene ventral, cambio de media sábana, valoración de piel, heridas y puntos de presión.
4. Volver a DP y repetir hacia el otro lado. Recolocar almohadas, rodete y empapador; coordinar brazos y cabeza; comprobar alineación y hemodinámica.

06 Prevención de úlceras por presión C/ CAMBIO

Alineación correcta y cambios frecuentes son la mayor garantía. Apósitos protectores en zonas de presión si precisa.

● Dedos de los pies	● Rodillas	● Genitales
● Mamas	● Codos	● Acromion
● Mandíbula	● Pómulos	● Orejas

07 Tolerancia a la alimentación C/ 6 H

Valorar reflujo gastroesofágico y cuantificar el aspirado gástrico.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO · JEFATURA UCI